

Aftöz Ülser ve Ekstraintestinal Bulgular

Rekürren aftöz ülserlerin ekstraintestinal bulgularla (artrit, eritema nodozum, üveit, piyoderma gangrenozum) birlikteliğinde IBD, çölyak ve sistemik inflamatuvar hastalıkları ayırt etmeye yönelik basamaklı karar aracı.

Aftöz stomatit

Ekstraintestinal bulgu

IBD taraması

Çölyak

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Aftöz ülser; ağız mukozasında ağrılı, sınırları düzenli, fibrinöz tabanlı, tekrarlayan erozyonlardır. Yılda üçten fazla atak, geç iyileşme, majör (>10 mm) veya herpetiform lezyon ve özellikle ekstraintestinal bulgu eşliği; basit rekürren aftöz stomatitin ötesinde sistemik/inflamatuar bir zeminin (IBD, çölyak, Behçet, beslenme eksikliği, hematolojik hastalık) taranmasını gerektirir.

Rekürren aftöz stomatit üç fenotipte sınıflanır: minör (<10 mm, skarsız iyileşen), majör (>10 mm, skar bırakan, uzun süreli) ve herpetiform (çok sayıda küçük ülser). Ekstraintestinal bulgu varlığı ülserin "sekonder" olabileceğinin en önemli göstergesidir.

Öykü — hedefli sorular

- Atak sıklığı, süresi, ülser boyutu ve iyileşme paterni (skar var mı)
- Kronik ishal, karın ağrısı, rektal kanama, perianal fistül/fissür/apse
- Kilo kaybı, büyüme hızında yavaşlama, pubertal gecikme, ateş
- Eklem ağrısı/şişliği, kırmızı-ağrılı göz, ışıktan rahatsızlık; bacakta ağrılı kırmızı nodüller; deri ülseri
- Genital ülser, tekrarlayan ateş atakları (PFAPA/Behçet ipuçları)
- Glutenle ilişki, ailede IBD/çölyak/otoimmün hastalık, ishal-kabızlık, demir eksikliği öyküsü
- İlaç kullanımı (NSAİİ, nikorandil), tekrarlayan enfeksiyon (sıklık nötropeni)

Muayene — sistematik bakı

- Boy-kilo-VYA persentil ve büyüme eğrisi; Tanner evresi
- Oral mukoza: ülser sayısı/lokalizasyonu, mukogingival "cobblestone", dudak şişliği (orofasiyal granülomatoz)
- Batın: hassasiyet, kitle; perianal inspeksiyon (skin tag, fistül, fissür)
- Eklemler: periferik artrit, aksiyel tutulum/sakroiliak hassasiyet, entesit
- Deri: pretibial eritema nodozum, alt ekstremitelerde piyoderma gangrenozum ülseri, paterji
- Göz: konjonktival kızarıklık; üveit için oftalmolojik değerlendirme gerektiren bulgular
- Solukluk, glossit, angüler keilit (demir/B12/folat eksikliği)

Ekstraintestinal bulgu + aftöz ülser birlikteliği, GİS semptomları hafif/silik olsa bile IBD ve çölyak taramasını zorunlu kılar; eritema nodozum ve periferik artrit sıklıkla hastalık aktivitesiyle paralel

02 Etiyoloji ve altta yatan mekanizmalar

Aftöz ülser + ekstraintestinal bulgu tablosunda ayırıcı tanı, immün-inflamatuvar zeminden beslenme eksikliğine kadar uzanır. Kategorilere göre hedefli tarama tanısal verimi artırır.

Basit rekürren aftöz stomatit

- İdiyopatik, aileselligin sık olduğu izole tablo
- Sistemik bulgu ve büyüme etkilenmesi yok
- Ekstraintestinal bulgu yokluğunda dışlama tanısı

İnflamatuvar barsak hastalığı

- Crohn: oral ülser, perianal hastalık, cobblestone mukoza
- EIM: pauciartiküler artrit, eritema nodozum, üveit, piyoderma gangrenozum
- Kalprotektin ve fekal inflamasyon belirteçleri yüksek

Çölyak hastalığı

- Aftöz stomatit ekstraintestinal prezentasyon olabilir
- Demir eksikliği anemisi, boy kısalığı, transaminaz yüksekliği
- Dermatitis herpetiformis, mine defektleri eşlik edebilir

Behçet ve otoinflamatuvar

- Oral + genital ülser, üveit, paterji, cilt lezyonu
- PFAPA: periyodik ateş + aft + farenjit + adenit
- Siklik ateş paterni ve atak süresi ayırıcıdır

Beslenme eksiklikleri

- Demir, B12, folat, çinko eksikliği aftöz ülseri tetikler
- Glossit, angüler keilit, solukluk eşlik eder
- Malabsorpsiyon (çölyak/IBD) sekonder olabilir

Hematolojik / immün

- Siklik nötropeni: ~21 günde bir ülser + ateş + enfeksiyon
- Primer immün yetmezlik, HIV; ilaç ilişkili ülser
- Nötrofil sayımı ve tekrarlayan enfeksiyon öyküsü yol gösterici

03 Karar akışı

Ekstraintestinal bulgu eşliğindeki aftöz ülserde alarm bulgusu ve inflamasyon belirteçlerine göre dallandırılmış yaklaşım.

BAŞLANGIÇ

Rekürren aftöz ülser + ekstraintestinal bulgu ile başvuru

Artrit, eritema nodozum, üveit veya piyoderma gangrenozumun aftöz stomatite eşlik ettiği çocuk.

ADIM 1

Ayrıntılı öykü + tam sistemik muayene + büyüme değerlendirmesi

Boy-kilo persentili, perianal inspeksiyon, eklem-deri-göz muayenesi; temel laboratuvar (tam kan, CRP, ESR, ferritin, albümin) ve fekal kalprotektin planla.

KARAR 1

Alarm bulgusu var mı? (kilo kaybı, büyüme geriliği, kronik/kanlı ishal, perianal hastalık, üveit)

Sistemik/organik hastalığı işaret eden kırmızı bayrakların varlığı sorgulanır.

EVET → sistemik hastalık şüphesi

HAYIR → alarm yok

HIZLANDIRILMIŞ TETKİK

IBD/sistemik inflamatuvar hastalık yolağı

Fekal kalprotektin, tam inflamasyon paneli, çölyak serolojisi; üst-alt GİS endoskopisi + biyopsi planla. Üveit varsa acil oftalmoloji, artrit varsa romatoloji ile eş zamanlı değerlendir.

HEDEFLİ TARAMA

Beslenme + çölyak taraması

Tam kan, ferritin, B12, folat, çinko, çölyak serolojisi (anti-tTG IgA + total IgA). Kalprotektin normale ve serolojiler negatifse basit RAS lehine izlem.

KARAR 2

Fekal kalprotektin yüksek VEYA çölyak serolojisi pozitif mi?

İnflamasyon belirteci veya seroloji pozitifliği tanısal yolu belirler.

EVET → doku tanısı

HAYIR → belirteçler normal

ENDOSKOPI/BİYOPSİ

IBD veya çölyak doğrulaması

EKSİKLİK DÜZELT + İZLEM

Kalprotektin yüksekse ileokolonoskopi + üst endoskopi (Crohn için özofagogastroduodenal biyopsi dahil); çölyak serolojisi pozitifse duodenal biyopsi ile Marsh evrelemesi ve tanı doğrulaması.

Beslenme eksikliği/basit RAS yönetimi

Saptanan demir/B12/folat/çinko eksikliğini replase et, topikal tedavi başla; ekstraintestinal bulgu için ilgili branşla ortak izlem. Belirteçler negatif kalır ve büyüme normalse 6-12 haftada yeniden değerlendir.

Öncelikle non-invaziv testler; alarm/pozitif belirteç varlığında endoskopik doku tanısına ilerle.

Aftöz ülser + ekstraintestinal bulguda kademeli tetkik planı

BASAMAK	TEST / EŞİK
Basamak 1 — Temel kan	Tam kan sayımı, CRP, ESR, albümin
Basamak 1 — Beslenme paneli	Ferritin, serum demir/TDBK, B12, folat, çinko
Basamak 2 — Fekal inflamasyon	Fekal kalprotektin (>50-250 µg/g)
Basamak 2 — Çölyak serolojisi	Anti-tTG IgA + total IgA (IgA eksikse anti-tTG/DGP IgG)
Basamak 3 — Endoskopi	İleokolonoskopi + üst GİS endoskopisi + biyopsi

BASAMAK	TEST / EŞİK
Basamak 3 — İnce barsak görüntüleme	MR enterografi (± MR enteroklizis)
Basamak 3 — Branş konsültasyonu	Oftalmoloji (yarık lamba), romatoloji, dermatoloji
Seçilmiş — Otoinflamatuvar	Seri nötrofil sayımı (siklik nötropeni), Behçet için paterji/

Çölyak serolojisi glutenli diyetle

Total IgA'yı unutma

Kalprotektin normal ≠ IBD dışlandı (alarm varsa endoskopi)

Aşağıdaki bulguların herhangi biri, basit rekürren aftöz stomatit tanısını dışlar ve hızlandırılmış inflamatuvar/sistemik hastalık değerlendirmesi gerektirir.

- Kilo kaybı, büyüme hızında yavaşlama veya pubertal gecikme

- Kronik ishal, gece semptomu, rektal kanama veya meleno

- Perianal hastalık: fistül, fissür, apse, skin tag

- Kırmızı-ağrılı göz, görme bulanıklığı, fotofobi (üveit)

- Piyoderma gangrenozum ülseri veya yaygın eritema nodozum

- Persistan/inflamatuvar artrit, sakroiliak/aksiyel ağrı, entesit

- Majör (>10 mm) veya skar bırakan, aylarca iyileşmeyen ülser

- Oral + genital ülser birlikteliği ve/veya paterji pozitifliği

- Periyodik ateş atakları ve tekrarlayan bakteriyel enfeksiyon (nötropeni)

- Yüksek CRP/ESR, hipoalbuminemi, trombositoz veya dirençli demir eksikliği anemisi

Üveit görme kaybı riski taşır: kırmızı-ağrılı göz veya fotofobide oftalmolojik değerlendirmeyi geciktirme. Piyoderma gangrenozum debridmanla kötüleşir (paterji); cerrahi manipülasyondan kaçınılmalıdır.

Tedavi iki kola ayrılır: (1) altta yatan hastalığın (IBD/çölyak/beslenme eksikliği) yönetimi, (2) aftöz ülser ve ekstraintestinal bulgunun semptomatik/aktif kontrolü. Dozlar yaklaşık olup ilaç etkileşimi ve organ fonksiyonuna göre bireyselleştirilmelidir.

Aşamalı tedavi ve dozlama

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Topikal kortikosteroid	Triamsinolon asetonid %0.1 orabaz veya deksametazon gargara, günde 2
Oral demir replasmanı	Elementer demir 3-6 mg/kg/gün (maks 150-200 mg/gün), bölünmüş
B12 / folat replasmanı	Folik asit 1 mg/gün PO; B12 eksikliğinde 1000 µg IM protokolü
Kolşisin	0.5-1.8 mg/gün (yaklaşık 0.5 mg/gün başla; maks ~1.8 mg/gün), bölünmüş
Sistemik kortikosteroid	Prednizolon 1-2 mg/kg/gün (maks 40-60 mg/gün), azaltarak kes

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Mesalazin (5-ASA)	50-80 mg/kg/gün (maks 4.8 g/gün), bölünmüş
Azatioprin	2-2.5 mg/kg/gün (TPMT/NUDT15'e göre ayarla)
Metotreksat	10-15 mg/m ² /hafta (maks ~25 mg/hafta) + folik asit
İnfliximab (anti-TNF)	5 mg/kg IV; 0-2-6. hafta indüksiyon, sonra her 8 haftada bir
Adalimumab (anti-TNF)	Ağırlığa göre subkutan (≥40 kg: 160/80/40 mg protokolü, sonra 40 mg 2 ha
Glutensiz diyet	Ömür boyu kesin gluten eliminasyonu (diyetisyen eşliğinde)

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG + MAKSİMUM)
Topikal steroid (göz)	Oftalmoloji yönetiminde topikal kortikosteroid + sikloplejik

Eritema nodozum ve periferik artrit genellikle altta yatan IBD/hastalık aktivitesi kontrol edilince geriler; ayrı immünsupresyon çoğu kez gerekmez. Anti-TNF öncesi TB (IGRA/PPD), hepatit B ve aşılama durumu mutlaka değerlendirilmelidir.

Tanı doğrulandıktan sonra izlem, hem ülser/ekstraintestinal bulgunun seyrini hem de altta yatan hastalığın aktivitesini ve tedavi güvenliğini kapsar.

Aktivite ve klinik izlem

- Her vizitte büyüme (boy-kilo-VYA persentili), Tanner evresi ve aktivite skorlaması
- Fekal kalprotektin ile mukozal iyileşme takibi; tam kan, CRP/ESR, albümin izlemi
- Aftöz ülser sıklığı ve süresi; ferritin/B12/folat/çinkonun periyodik kontrolü
- Ekstraintestinal bulguların (eklem, deri, göz) seyri; üveitte planlı oftalmoloji takibi
- Çölyakta anti-tTG'nin diyet uyumu göstergesi olarak izlenmesi

Tedavi güvenliği ve destek

- Tiyopurin/metotreksatta hemogram ve karaciğer enzim izlemi; TPMT/NUDT15 durumu
- Anti-TNF öncesi TB/hepatit taraması, canlı aşı planlaması ve enfeksiyon uyanıklığı
- Kortikosteroidde süre sınırlaması, kemik sağlığı ve büyüme etkisinin gözetimi
- Beslenme desteği, D vitamini/kalsiyum, aşı takvimi güncelliği
- Multidisipliner eş izlem: romatoloji, dermatoloji, oftalmoloji ve diyetisyen ile ortak plan

Hedef; sadece aftöz ülserin baskılanması değil, altta yatan hastalıkta klinik + biyokimyasal (ve mümkünse mukozal) remisyona ulaşmak, büyümeyi ve yaşam kalitesini korumaktır. Tedaviye yanıtız veya alevlenen ekstraintestinal bulguda tanı ve tedavi basamağı yeniden gözden geçirilmelidir.

Kaynaklar

1. van Rheenen PF, Aloï M, Assa A, et al. The Medical Management of Paediatric Crohn's Disease: an ECCO-ESPGHAN Guideline Update. J Crohns Colitis. 2021.
2. Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, et al. Management of Paediatric Ulcerative Colitis (ECCO-ESPGHAN Guidelines), Parts 1-2. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018.
3. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó I, et al. ESPGHAN Guidelines for Diagnosis of Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020.
4. Rome Foundation. Rome IV Diagnostic Criteria for Functional Gastrointestinal Disorders (Childhood). 2016.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar destek aracıdır; hastaya özgü klinik yargının, güncel kılavuzların ve yerel protokollerin yerini almaz. Tüm ilaç dozları başlamadan önce ağırlık, organ fonksiyonu, etkileşim ve güncel monograflara göre doğrulanmalıdır.